Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 2

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери 3

2.6 Анамнез 3

3. Диагностика 3

3.1 Физикальное обследование 3

3.2 Лабораторные исследования 4

3.3 Степень кровопотери у взрослых 4

3.4 Консультации специалистов 4

4. Лечение 4

4.1 Остановка кровотечения 5

4.2 Медикаментозная терапия 6

5. Профилактика. Показания к госпитализации 6

5.1 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 7

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Первым мероприятием при кровотечении из передних отделов полости носа является плотное прижатие крыльев носа к носовой перегородке на 5 минут и более.
- Если кровотечение не угрожает жизни, начинают с местной остановки кровотечения (прижатие крыльев носа, сосудосуживающие средства, коагуляция или тампонада); к коррекции гемостаза или отмене антикоагулянтов переходят лишь после этого.
- При продолжающемся кровотечении, источник которого визуализировать не удаётся, необходима передняя тампонада полости носа.
- Артериальное давление измеряют у каждого пациента, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить объём кровопотери.
- Показаниями к госпитализации являются неэффективность первичных мероприятий, значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение, признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология, высокий риск рецидива; госпитализация обязательна во всех случаях переливания крови, задней тампонады, перевязки сосудов и эмболизации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Под носовым кровотечением понимается кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Этиология

Различают посттравматические, в том числе послеоперационные, и спонтанные носовые кровотечения. Спонтанное кровотечение является симптомом местного или общего заболевания.

Поражение сосудов слизистой оболочки полости носа наблюдается при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях полости носа и околоносовых пазух, сосудистых мальформациях, гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение в большинстве случаев обусловлено повреждением слизистой оболочки (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение встречается очень редко, приблизительно в одном случае из 10 000. При возникновении кровотечения в этом возрасте необходимо исключить заболевания крови и врождённую патологию, в частности гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму развития выделяют кровотечения, обусловленные изменениями сосудов полости носа, нарушениями свёртывания крови или сочетанием этих причин. По источнику различают кровотечения из передних и задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки и внутричерепных сосудов.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь вытекает преимущественно наружу, при заднем стекает в носоглотку.

Пациенты предъявляют жалобы на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки, недомогание. При заглатывании крови отмечаются дискомфорт в животе, тошнота, стул чёрного цвета.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Отсутствует	Признаки отсутствуют	до 10% объёма циркулирующей крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое артериальное давление выше 100 мм рт. ст., конечности холодные, диурез не нарушен	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое артериальное давление 90–100 мм рт. ст., пульсовое давление снижено, беспокойство, потливость, бледность кожных покровов, диурез менее 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс более 120, систолическое артериальное давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность кожных покровов, конечности холодные, сухость языка и кожи, анурия	более 35% (более 1750 мл)

2.6 Анамнез

При сборе анамнеза уточняются время начала, длительность и частота кровотечений, сторона предшествующих кровотечений, случаи госпитализации и переливания крови в связи с ними. Выясняется приём антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, наличие артериальной гипертензии, коагулопатий, анемии, кровотечений у родственников, травм и операций на полости носа и околоносовых пазухах.

Носовое кровотечение, особенно рецидивирующее, может быть первым проявлением коагулопатии, наследственной геморрагической телеангиэктазии, опухоли полости носа или носоглотки, заболеваний печени или почек. Беспричинное появление синяков и петехий, кровотечения из внутренних органов в анамнезе свидетельствуют в пользу системного нарушения свёртывания крови.

Кровотечение на фоне приёма антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать их отмены или снижения дозы. У таких пациентов чаще отмечаются рецидивы и кровопотеря более 250 мл, требующая переливания крови. Риск кровотечения повышают также многие назальные спреи, в том числе сосудосуживающие и глюкокортикостероидные, и некоторые наркотические вещества.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается при подтверждении кровянистых выделений из носа данными риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Физикальное обследование

Всем пациентам с носовым кровотечением требуется осмотр врача-оториноларинголога с оценкой общего состояния, поиском источника кровотечения и определением тактики лечения.

При необходимости госпитализации следует выбирать стационар, в котором имеется дежурный оториноларинголог. Если во время кровотечения пациент не был осмотрен оториноларингологом, в том числе в связи с самопроизвольной остановкой кровотечения, необходима плановая консультация оториноларинголога.

Для исключения гиповолемии оцениваются пульс, уровень сознания, состояние кожных покровов и слизистых оболочек. Обморок, тахикардия, тахипноэ, бледность кожных покровов свидетельствуют о гемодинамических нарушениях вследствие кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых оболочках при отсутствии травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания крови.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа, а также при наличии носовых кровотечений у родственников следует искать телеангиэктазии на слизистой оболочке полости носа и рта, чтобы исключить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезни Рандю—Ослера—Вебера).

У всех пациентов определяют артериальное давление, что позволяет выявить артериальную гипертензию и оценить гиповолемию; артериальная гипотензия может свидетельствовать о значительной кровопотере.

Если источник кровотечения не визуализируется при передней риноскопии, следует выполнить эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки.

Повторяющееся одностороннее кровотечение может быть первым признаком опухоли, не визуализируемой при передней риноскопии, а у детей также инородного тела.

3.2 Лабораторные исследования

Общий анализ крови позволяет оценить постгеморрагическую анемию и уровень тромбоцитов; о кровопотере судят по уровню гемоглобина и гематокриту.

3.3 Степень кровопотери у взрослых

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	более 120	более 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	более 1500 мл	менее 80	менее 20

При рецидивирующих кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют систему гемостаза: определяют международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромбиновое время. Определение МНО имеет особое значение у пациентов, получающих варфарин: значение выше 4,5 является прогностически неблагоприятным.

На фоне приёма прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.4 Консультации специалистов

Артериальная гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие заболевания, влияющие на течение кровотечения, требуют консультации терапевта или педиатра.

Пациентов с рецидивирующими кровотечениями и лабораторными признаками тромбоцитопатии или коагулопатии направляют на консультацию к гематологу.

4. Лечение

Целью лечения является остановка кровотечения, устранение факторов риска и коррекция последствий кровопотери, в том числе гиповолемии и анемии.

Если кровотечение не угрожает жизни, его в первую очередь останавливают местными методами: прижатием крыльев носа, применением сосудосуживающего средства, коагуляцией или тампонадой. Корригировать гемостаз или отменять антикоагулянты и антиагреганты следует лишь после этого, поскольку системная коррекция сопряжена с риском осложнений, прежде всего тромбоэмболических.

4.1 Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов полости носа прежде всего плотно прижимают крылья носа к носовой перегородке на 5 минут и более, как правило на 5–15 минут. Предварительно пациент сморкается для удаления сгустков и находится в положении сидя или стоя с небольшим наклоном головы вперёд. Манипуляция может быть выполнена самим пациентом. Если кровь продолжает стекать, источник кровотечения, вероятнее всего, расположен глубже и требуются другие методы остановки.

При продолжающемся кровотечении и установленном источнике взрослым рекомендуется аппликация на источник турунды с сосудосуживающим средством; взрослым и детям возможна аппликация гемостатического средства.

Однократно на турунде применяется #ксилометазолин или #эпинефрин; #оксиметазолин в виде спрея — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 3 раза в сутки в течение 3–5 дней (знак # обозначает применение вне инструкции). При артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемии головного мозга сосудосуживающие препараты применяются с осторожностью.

Возможна однократная аппликация на источник кровотечения турунды с #транексамовой кислотой (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилатом (взрослым и детям).

Когда источник продолжающегося кровотечения обнаружить не удаётся, прибегают к передней тампонаде полости носа.

Преимуществом рассасывающихся материалов, например коллагеновой гемостатической губки, является отсутствие необходимости их удаления, поскольку при удалении тампона кровотечение может возобновиться. В связи с этим при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной геморрагической телеангиэктазии или заболеваниях крови, по возможности следует использовать рассасывающиеся материалы. У детей источник кровотечения, как правило, располагается в передних отделах, поэтому, если поведение ребёнка позволяет, предпочтительны бестампонные методы остановки; если ребёнок не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов полости носа не удаётся остановить передней тампонадой, переходят к сочетанной передней и задней тампонаде с установкой тампона в области хоан и носоглотки.

Пациенты с задним тампоном подлежат наблюдению и лечению в стационаре. Нить или фиксатор не должны оказывать избыточного давления на крыло носа во избежание образования пролежня. Ряд авторов указывает на необходимость системной антибактериальной терапии при задней тампонаде.

Продолжающееся кровотечение из установленного источника служит показанием к коагуляции кровоточащего сосуда.

Коагуляция может выполняться химическим методом (нитратом серебра), электрокоагуляцией, лазером или радиоволновым методом. Предварительная аппликация сосудосуживающего средства повышает эффективность коагуляции.

При неэффективности коагуляции и тампонады рассматривается вопрос об эмболизации сосудов или перевязке артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эффективность эмболизации достигает 87%, однако осложнения при ней развиваются чаще, чем при перевязке; эмболизация может выполняться под седацией и без удаления тампонов.

При рецидивирующих кровотечениях из зоны Киссельбаха рекомендуется отслойка слизистой оболочки перегородки носа.

При субатрофии слизистой оболочки и выраженном искривлении перегородки носа от операции воздерживаются.

4.2 Медикаментозная терапия

Повышенное артериальное давление требует антигипертензивной терапии, которая позволяет уменьшить кровопотерю и риск рецидива.

При недостаточной эффективности первичных мероприятий применяют гемостатические средства: транексамовая кислота (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновая кислота, аминометилбензойная кислота, этамзилат в дозах согласно инструкции. При продолжающемся кровотечении предпочтительно внутривенное введение, таблетированные формы используют для профилактики рецидивов.

Системное применение этамзилата оправдано только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой оболочки.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года показано внутривенное введение транексамовой кислоты в максимально ранние сроки, предпочтительно в первые 3 часа после травмы.

Ведение пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности осуществляются совместно с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводится менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, детям от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Возможно также профилактическое введение, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки рекомендуются увлажняющие и ранозаживляющие средства для слизистой оболочки полости носа.

Эти средства уменьшают сухость и образование корок, что позволяет пациенту избегать самостоятельного туалета носа; применяют их и при субатрофическом рините.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Пациентам разъясняются факторы риска повторного кровотечения, способы его самостоятельной остановки и показания для обращения к врачу.

Детям, родителям и пожилым пациентам следует объяснить недопустимость пальцевой травмы слизистой оболочки носа; пожилым пациентам важно также указать на связь риска кровотечения с приёмом лекарственных препаратов и подъёмом артериального давления. Сухость слизистой оболочки вызывают кислородные канюли и дыхательные аппараты повышенного давления. Пациентам, получающим варфарин, обязателен контроль МНО. При рецидивирующих кровотечениях на фоне применения назальных спреев их дозу уменьшают и обучают пациента правильной технике применения.

Если кровотечение связано с повышением артериального давления, для подбора антигипертензивной терапии пациента направляют к терапевту, педиатру или кардиологу.

5.1 Показания к госпитализации

Решение о необходимости госпитализации после передней тампонады принимается с учётом длительности кровотечения, объёма кровопотери, признаков гиповолемии, сопутствующих заболеваний, типа тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике обследование и лечение осуществляют в приёмном или оториноларингологическом отделении.

На фоне гипертонической болезни кровотечение останавливает оториноларинголог в приёмном отделении, после чего пациент госпитализируется в терапевтический стационар для нормализации артериального давления.

При незначительном или остановившемся кровотечении обследование пациента возможно в амбулаторных условиях.

Показаниями к госпитализации являются неэффективность первичных мероприятий, значительная кровопотеря или интенсивное кровотечение, признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология, высокий риск рецидива. Госпитализация обязательна во всех случаях переливания крови, задней тампонады, перевязки сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удаление тампонов в амбулаторных условиях невозможно.

Значительной считается кровопотеря более 10% объёма циркулирующей крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным считается кровотечение более 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации по поводу кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и более трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Пациент выписывается при стойкой остановке кровотечения, отсутствии признаков гиповолемии, стабильной гемодинамике и компенсации сопутствующих заболеваний.

Исход во многом определяется скоростью и объёмом кровопотери: массивная кровопотеря более 40% объёма циркулирующей крови может быть несовместима с жизнью.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательности обозначен как «уровень доказательств – 4» вместо принятой формулировки «уровень достоверности доказательств».
- В оглавлении PDF-версии вместо номеров страниц нескольких разделов указано «Ошибка! Закладка не определена».